

Krankheit	Anamnese*	Status**	Prozedere/Abklärung	Therapie	Kommentar
Allerg. Konjunktivitis	Frühjahr, FK-Gefühl, wässriges Sekret (selten zäh-schleimig), Rötung, Juckreiz, Schwellung, Rhinorrhoe, Asthma, Husten, ev. Visusabfall, Allergenexposition, Asthma, Rhinitis	Inspektion (Konj. Injektion) Ektropionieren Vorderes Auge Visus LK	Allergolog. Abklärung (Desensibilisierung)	Lokale Antihistaminika (falls Asthma systemisch), Steroid-Trpf. , Expositionen vermeiden	Gilt f. alle Konjunktividen: Nie Steroide geben! I.d.R. bilateral, Sehschärfe ok Oft Frühling (Hausstaub perennial)
Sicca-Syndrom (Keratokonj. Sicca)	Frauen postmenopausal, Rötung, FK-Gefühl, Abends/PC/Wind/Winter schlimmer, ev. Visusabfall Trockener Mund (Sjögren-Syndrom), Rheuma, Menopause	Inspektion Ektropionieren Vorderes Auge Visus Schirmertest (<5mm pro 5min) LK	Ev. Gynäkologie	Tränenersatzmittel: Künstliche Tränen (Tropfen), Plugs	Chronischer Prozess, an Sjögren-Sy denken.
Bakt. Konjunktitis	Rötung, schleimig-eitriges Sekret, verklebtes Lid, Krusten, Schwellung, , FK-Gefühl, ev. Blutung, Beläge/ Membranen, Follikel/ Papeln, ev. Visusabfall, i.d.R. bds., AZ gut Nach Ausfluss vaginal fragen wegen Chlamydien!!	Inspektion (Konj. Injektion) Ektropionieren Vorderes Auge (z.B. HH-Infiltr.) Visus LK (präaurikulär + submand.)	Abstrich (falls chron. K./>3Wo., NG)	Akute K.: keine AB Chron. K + NG.: AB (Tpf./Salbe)	Bei Chlamydieninfektion bluriger Abstrich machen da Erreger sich intrazellulär befinden
Virale Konj. (u.a. Keratokonj. Epidemica: Adenoviren 6+18)	Rötung, Tränenfluss (wässrig), Schwellung, 1 Auge zuerst, FK-Gefühl, ev. Visusabfall, grippale Prodromi, Umfeld, zuerst einseitig dann oft bds. K. epidemica: beginnt oft nasal, Umfeld	Inspektion (Konj. Injektion) Ektropionieren Vorderes Auge (z.B. HH-Infiltr.) Visus LK (präaurik. LK geschwollen)	Ev. Abstrich	Keine spez. Th., abschwellende Augentropfen Bei V.a. K. epidemica: Krankschreiben für 2 Wo.! Hygiene!	kein Eiter, Umgebungs-Anamnese oft +! Kontagiös! Häufigste infektiöse Konj., Adenoviren
Blepharitis	Lidrand verklebt, unscharf, entzündet, schuppig	Inspektion Ektropionieren Vorderes Auge Visus Schirmertest LK	Ev. Abstrich	Ev. AB	
Pinguecula/Pterygium	Beginn, Wachstum, störend? Rezidiv?	Inspektion Ektropionieren Vorderes Auge Visus Schirmertest LK		Pinguecula: keine Pterygium: Chir. Falls störend	Pterygium: BH-HH Pinguecula: BH-BH
Schielen (Augenmuskelproblematik)	DB, immer binokulär, selbst bemerkt, immer/manifest od. nur latent (Alk, Müdigkeit, Stress), bereits in Kindheit? (keine DB) Blickrichtungsabhängig? Trauma? (Orbitabodenfx)	Inspektion: Augenstellung, C-Reflex Motilität (6 Duktionsbew. →konk.(in alle Blickrichtungen gleich) od. inkonk. Schielen,	Bagolini-Test, Strabismus-Sprechstunde, Prismencoverstest (Quantifizierung)	Latentes Schielen: Korrektur Fehlsichtigkeit, Prismsgläser krankes Auge, Chirurgie Manifestes Schielen: Prismengläser? Okklusion	Konkomitant (manifestes Schielen) vs. Inkonkomitant (latentes Schielen). Falls monokuläre DB →vorderes Auge untersuchen (Problem brech.

		Ab- + Aufdecktest , altern. Coverttest → manifest od. latent, Prismencovertest), Visus , Vorderes Auge (falls monokuläre DB), Pupillenreaktion (III-Parese) inkl. Konvergenz Neurostatus : Hirnnerven		gesundes Auge, Chirurgie	Medien)
Abduzensparese	Auge schaut nach medial (Esotropie), DB bei Blick nach lateral				
Trochlearis-Pares	Betroffenes Auge steht höher + lateral + ist aussenrotiert, Kopf wird zur Gegenseite geneigt. DB bei Blick nach unten + medial + bei Kopfneigung zur betrof. Seite.				
Okulomotrius pares	Auge schaut nach aussen unten, Ptose, Mydriase, Pupillenreaktion gestört.				Falls nur äussere Parese Pupillenreaktion intakt.
Bakt. Keratitis	Schmerzen, rotes Auge, ev. Eiter, ev. Visusabfall, Photophobie, oft bds. RF: Linsen, Erosion, Immunschwäche, Steroide, Fieber	Inspektion (Injektion, ev. Hypopyon), Ektropionieren , vorderes Auge inkl. Fluoreszin (Trübung, Infiltrat, Ulkus ev.), Cornea-Reflex , Visus , GF ,	HH-Abstrich , ev. Hospitalisation	AB-Tpf empirisch, KL-Karenz (mind. 14 T), Hygiene-Instruktion , falls zentale Narbe Keratoplastik (Transplantat)	bei Linsen i.d.R. Pseudomonas od. Akanthamöben Kann zum Verlust d. Auges führen wenn Perf. d. HH > Endophthalmitis!
HSV-Keratitis (Keratitis dendritica)	Sz., rotes Auge, Visusabfall, Primärfekt (Bläschen) am Lid od. Konjunktivitis od. Blepharitis, unilateral	Inspektion , Ektropionieren , vorderes Auge inkl. Fluoreszin (Dendritica-Figur), Cornea-Reflex (Sens. ↓!), Visus , GF	Abstrich	Zovirax-Sable (falls EP-Befall), lokale Steroide (nur falls Stroma-Befall, bei Dendritica-Figur KI!), ev. syst. Virostatika	Zovirax ist nie falsch Prognose i.d.R. gut, aber Rezidive mit Narben.
Herpes-Zoster-Keratitis (Zoster ophthalmicus > N. Trigemini)	Unilaterale Haut-Effl. in Dermatom, Immunsupr., Steroide, Konjunktivitis, Keratitis, Skleritis, Uveitis, influenza-artige Erkrankung (Fieber, Kopf-Sz., red. AZ), Juckreiz, Brennen, Neuralgie	Inspektion (Bläschen, Hutchinson-Zeichen → oft Augenbeteiligung), Ektropionieren , vorderes Auge inkl. Fluoreszin , Cornea-Reflex (Sens. ↓), Visus , GF , RAPD , Hirnnerven , LK	Abstrich	Valtrex (Valaciclovir), top. Steroide , Zovirax , Gabapentin falls Neuralgie	Ist ein Rezidiv einer Varizellen-Infektion. DD Zoster oticus: Befall N. vestibulocochlearis
Fazialisparese	Augenschluss fehlt, hängender Lidwinkel, brennenden Trockenes Auge, ev. Ulzera, ev. Visusverlust = sterile Keratitis	Visus , Inspektion , vorderes Auge , Neuro (Fazialis/Dermatome/ Hirnnerven/Sens.), LK , RAPD	Serologie (Borrelien), BE , ev. MRI falls neurolg. Ausfälle	Steroide , Valacyclovir , Verband , Augentropfen	Oft idiopath. od. i.R. DM od. infektiös (H. Zoster, Herpes-Simplex, Borrelien, etc.) Zentrale (Stirne noch runzeln) vs. periphere Parese (Stirne nicht mehr runzeln)
Fremdkörper/Erosio Corneae	FK od. nur noch Rosthof, Sz., Tränen, rotes Auge, Visus ↓	Inspektion , Ektropionieren , vorderes Auge inkl. Fluoreszin , Cornea-Reflex , Visus	Peripherer FK: HA Zentraler FK: Ophtalm → FK via Pinzette/Wattestab entfernen, Rosthof rausbohren Ev. CT (intraokul. FK)	AB (Salbe), Okklusionsverband (satt), Tetanus ev. Falls intraokul. FK > schneller Wundverschluss HH/Sklara >Versorgung Retina“	Erosio: oft Fingernagel od. Zweig i.d.R. folgenlose Heilung „FK kann auch am nächsten Tag rausgenommen werden ausser Holz + Kupfer u.a. schnell raus!

Verätzung	Sz.! Visusabnahme, Blepharospasmus, rotes Auge od. blass (Ischämie)	Inspektion (Vernarbungen, trübe HH, falls schlimm keine konjunkt. Gefäße sichtbar, sonst Konjunktivitis), Visus, vorderes Auge (inkl. Fluoreszein >Erosio)	Spülen Spülen Spülen , Überweisung Augenklinik (i.d.R. Hospitalisation)	Blepharospasmus überwinden → Anästhetika, SPÜLEN (NaCl), Entfernung FK (Ektrop.), Ascorbinsäure/Vit. C (hochdosiert), Debridement , ev. top. Steroide	Nach Tagen E.-Zeichen (LK, Uveitis anterior, Gewebeinschmelzung, Ulkus, Perf.) Komplikationen: Katarakt, Glaukom, Neovaskul., etc. Generell: schlechte Prognose
Keratitis photoelectrica/ Verblitzung	Starke Sz., Blepharospasmus (Unters. schwierig), plötzlicher Visusverlust (denken sie erblinden)	Inspektion, Ektropionieren, vorderes Auge inkl. Fluoreszin (pos.!), Cornea-Reflex, Visus		AB (Salbe), syst. Analgetika, KEINE lokalen Analgetika mitgeben!!!!	Keine lokalen Anästhetika! Folgenlose Heilung. Ursache: UV (Sonne+Schnee z.B.), Schweissen)
Keratokonius	Verdünnung und Vorwölbung HH, beginn mit 15-20 progredient bis 40, Narben, Pat. werden immer myoper	Inspektion, Cornea-Lichtreflex, Extropionieren, vorderes Auge, Visus (Mopie)		Korrektur: Brille/KL, UV-Vernetzung mit Riboflavin + UV-Licht , ev. Keratoplastik	
Endotheldysrophie (Fuchs)	Oft Rotes Auge, Vernarbungen (chron. Prozess), Visusabfall (fast bis zur Erblindung), morgens schlechter	Inspektion (Blasen auf HH, HH s. trüb, ev. Vernarbungen), Cornea-Lichtreflex, Extropionieren, vorderes Auge, Visus (Myopie), Fundus (trüb)		Keratoplastik od. Endotheltransplantation , (>Immunsuppr. + Steroide)	Endothelzellzahl d. HH ↘
Katarakt (Grauer Star)	Langsam Visus ↘, keine Sz., oft bds., Nebelsehen, Auge gelb-trüb, alles gelblich (Farbwahrnehmung), ev. Leben ohne Brille wieder möglich. Immnsupr./Steroide!	Inspektion, Visus, vorderes Auge (Linse trüb + dicker, Fundusreflex ↘ + fleckig), Funduskopie (Fundus schlecht einsehbar)	Bei Kindern + Engwinkelglaukom (Komplik. Katarakt) immer Ops, bei Erw. nach Wunsch	Ev. Brille (korrigiert Myopie i.R. Katarakt), Chirurgie: IOL	Primär: Alter Sekundär: Immunsupr./Steroide, postop, Trauma, Radio Kongential: Notfall-Ops (Lentektomie), neue IOL erst ab 1-jährig möglich.
NH-Ablösung/Amotio	Sz-loser plötzlicher Visusabfall (falls periphere Ablatio oft nicht sofort bemerkt, sondern erst bei gew. Blicken Skotome + Schleier, Visus recht erhalten), Blitze, Flimmern, Russregen/Mouches volantes, Vorhang, Schatten, GF-Ausfälle	Inspektion, Visus, GF, Vorderes Auge, Fundoskopie, Fundusreflex	OCT	Verschluss Loch (Laser, Kryo; v.a. Hufeisenforamina behandeln!!!), Chirurgie: Elim. Traktion (ev. Vitrektomie), Annäherung Skelra an Loch (Plomben), Cerclage oder Endotamponade	Periphere Ablatio's schnell behandeln, Zentrale eh zu spät. Je kürzer Dauer der Ablatio + je peripherer desto besser Prognose, Erholung ca. nach 1 J.
GK-Blutung	Plötzlicher Sz.-Loser Visusverlust	Visus, GF, vorderes Auge, Fundoskopie (nichts sichtbar!!)		Vitrektomie	Ursachen Neovaskul. (DM, Gefäßverschlüsse), Trauma, Ablatio
Makulopathie (AMD, Makulaforamen, epiretinale Membranen, RCS)	Visusabfall (Lesen + TV n. möglich), Zetralskotome, z.T. Erblindung, Metamorphopsien (v.a. bei RCS + epiret. Membranen)	Inspektion, vordere Augenabschnitte, Visus, GF, Fundoskopie	OCT, Autofluoreszenz, Fluoreszenzangiographie	AMD: trockene Form keine Th.; feuchte Form: Laser , intravitreal anti-VEGF (Lucentis, Avastin), operativ , ev. Photodyn. Th. (Bestrahlung m. Licht) Makulaforamen: Vitrektomie, Entf. Membranen + IML, Endotamponade Epiretinale M.: analog M-Foramen, aber nur falls gewünscht RCS: akut n. nötig, chron: Laser	

Glaukom (85% primäres Offenwinkelglaukom)	Oft lange keine Smypt., falls fortgeschritten GF-Ausfalle (mittl. Peripherie, dann Aussen, zuletzt zentral, bogenförmig, inselartig) i.R. Optikusatrophie (Exkavation Papille), schleichende Erblindung, Farbensehen + Visus fällt als erstes aus	Visus, GF, Augendruck, vorderes Auge*, Fundoskopie (Papille: Gefaesse n. nasal verschoben, Exkavation tiefer + grösser), Farbensehen	Gonioskopie (Kammerwinkel), Tonometrie (Druckkurven Tagesverlauf), Perimetrie (GF), Nervenfaserschicht-Dx (Papille), sek. Ursachen suchen, dann wäre es aber ein Sek. OWG.	1. Druck senken (Medis: CAH, B-BI., Mannitol), Laser (bei WBG), Chirurgie (Trabekuloplastik bei OWG >Abfluss ↗, Trabekulektomie, Drainage, etc.) 2. Ursache suchen (nur bei POWG keine Ursache) 3. Kontrollen jährlich Glaukom ist eine chron. Erkrankung, nicht heilbar, aber kontrollierbar. *sieht nichts ausser wenn WBG POWG: klass. Glaukom, v.a. ab 40-60 J. Dx zufaellig od. wenn fortgeschritten. Ursache unklar. Ab 40. Jährliche Kontr.!	
Glaukomanfall	Plötzlich anfallsartiger Sz.+ langsam zunehmender Visusabfall + Regenbogenfarben um Lichtquellen! (Halos) Rotes Auge, red. AZ, Kopf-Sz., Erbrechen, Photphobie, unilateral Trigger: Nachts, Sympathikus (Horrorfilm), Hyperope (Auge zu kurz)/Asiaten + Alte	Visus, Augendruck, vorderes Auge (Spalt: VK eng/schmal, Iris vorgewölbt, HH leicht trüb, mittelweite Pupillen), ev. GF + Fundoskopie (sieht nichts speziell)	Notfall! Ev. mit Gonioskop Kammerwinkel messen (Ohne Th. Erblindung)	1. Anfall behandeln Diamox (CA-Hemmer) p.o. od. i.v., Mannitol i.v., B-Blocker 2. Pilocarpin (>Miosis) 3. Laser-Iridotomie od. chirurg. Iridektomie	CAH: Kammerwasserprod. ↘ Mannitol: Diuretikum B-Blocker: bei Asthma KI (Bronchokonstr.) Pat. darf erst nach Hause wenn Iridotomie auch am anderen Auge gemacht wurde!
Arterieller Gefässverschluss	Plötzlicher sz.-loser Visusverlust, GF-Ausfall, meist unilateral, oft im Alter cvRF's: Hypert + Rauchen! Arteriosk., DM, Dyslip., Adip.,	Visus, GF, Pupillen (RAPD), Fundoskopie (NH-Ödem >helles /gelbes Areal, denn sieht Choroidea nicht, kirschröter Fleck (Zentralarterienverschluss), Art. knapp sichtbar)	Spaltlampe OCT (Ödem), Fluoreszenzangio (bei allen Gefässproblemen indiziert) Suche Emboliequelle: Carotisdoppler + TTE/TEE, EKG Bei Zentralart.verschluss M. Horton ausschliessen!(Biopsie)	1. Perfusionsdruck ↗: → Augendruck ↘: CA-Hemmer (Diamox) , Parazentese , Bulbusmassage → art. Druck ↗: Flachlagerung, Infusion 2. Fibrinolyse/Heparin (selten) 3. Hämodilution (Infusion) 4. RF's therapieren	Amaurosis fugax: falls selbe Symptomatik aber Besserung innert kürze → Durchblutungsproblem. Prognose: i.d.R. schlecht Zentralarterienverschlusss od. nur Astverschluss (nur innere NH-Schichten betroffen)
AION	Visusabfall, horizontale GF-Ausfälle, RAPD	Visus, GF (horizontale Ausfalle falls Papille), Pupillen (ev. RAPD also Swinging flash light), Fundoskopie (Papille blass/unscharf/ geschwollen i.R. Ischämie)	Spaltlampe, OCT , Fluoreszenzangio (KM-Austritt), Nervenfaserprofil (sieht untergegangene Neuronen), Ausschluss M. Horton via Temporalis-Biopsie	1. Perfusion ↗: Ca-Antag. , Bulbusmassage, Senkung Augendruck 2. Lyse/Heparin unklar 3. RF's therapieren	Akute art. Durchlutungsstöerung v. Papillen-Arteriolen >Optikusinfarkte >schlechte Prognose
M. Horton (arteritische Form d. AION)	Visusabfall, GF-Ausfälle (horizontal), RAPD, Kopf-Sz. (A. temp.), Kau-Sz., Fieber		BSG + CRP Biopsie A. temporalis Spaltlampe, OCT , Fluoreszenzangio (KM-Austritt), Nervenfaserprofil	1. Hochdosierte Steroide i.v. , Reduktion auf Erhaltungsdosis sobald CRP/BSG normal, mind. 12 Mte. 2. CRP/BSG-Kontrollen, dann Erhaltungsdosis und ausschleichen	In 25% dann noch das 2. Auge beteiligt! Hohes Erblindungsrisiko! Formen: arteritische AION od. Zentralarterienverschluss
Venöser Gefässverschluss	Langsam-subakut (im Gg. zu art. Verschluss), Visusabfall, GF-Ausfall cvRF: Arteriosk., Hypert., Dyslip., Glaukom, etc.	Visus, GF, Pupillen, Fundoskopie (Venen gestaut, viele kl. Blutungen ev., Exsudate)	Spaltlampe, OCT , Fluoreszenzangio (KM-Austritt)	1. Hämodilution 2. Laserkoagulation (falls ischämischer ZV-Verschluss) 3. Anti-VEGF (bei Makulaödem) 4. RF's therapieren. 5. Kontrollen	Venenast- vs. ZV-Verschluss →ZV: - Ischämisch: schlechte Prognose f. Visus, Neovaskul. (VEGF), Makulaödem, Rubeosis iridis, etc. - Nicht-Ischämisch: gute Prognose

Diabet. Retinopathie (DR)	Visusabfall (Makulopathie), GF-Ausfälle (Neovaskul.) RF: DM + Hypertonie! u.a.	Visus, GF, Fundoskopie (Leckagen → Exsudate, Kapillarschwund, Blutungen, Neovaskul. in Papillenregion, Mikroaneurysmen)	Fluoreszenzangio (s. Austritt KM aus Leckagen)L	1. Laserkoagulation (mild bei schwerer nicht-prolif. Form, panretinal bei prolif. Form) 2. Vitrektomie+Laser falls s. schwere prolif. RP (schlecht) 3. DM + BD therapieren od. einstellen 4. Kontrollen jährlich (Ophta, Diabetologe, Niere, Podologe) Milde nicht-prolif. DR: nur Punkte 3 + 4	Nicht-Prolif. DR (keine Neovaskul.!) vs. Prolif. DR (Neovaskul. + GK-Blutungen, traktive NH-Ablatio's, Klinik bei beiden ca. gleich Diabet. Makulaödem: Makula-Beteiligung (Ödem/Exsudate, Ischämie) i.R. proliferat. DR. Th: Laser, immer mehr aber Anti-VEGF, Controller DM + BD, Kontrollen. Falls Diffuses DME keine effektive Th. >Anti-VEGF
Endokrine Orbitopathie	Exophthalmus, Druckgefühl in Orbita, Konjunktivitis, v.a. morgens Oberlidenschwellung, Lichtempfindlichkeit, Schielen >DB (restriktive Myopathie), Hyperthyreose-Sympt. (Tremor, Schwitzen, Tachyk., Schwitzen) erfragen	Inspektion (Lidretraktion, Konjunkt., Exophthalmus, stechender Blick, Lid schaut nach unten), Visus, Farbsinn, GF, Motilität (inkonk. Schielen), Cornea-Lichtreflex, Pupillen (RAPD ev.), Exophthalmus (meist asymmetr.) messen, Fundoskopie, SD palpieren	BE (SD-Hormone + AK), Exophthalmometrie, CT/MRI Orbita (A-Muskeln verdickt + enhant)	1. Steroide systemisch 2. ev. Chirurgie (Orbitadekompression v.a. wenn Optikusneuropathie) 3. Behandlung Hyperthyreose 4. Ev. Bestrahlung	I.d.R. i.R. M. Basedow, ev. weil kreuzreagierende Ag in Orbita, Nachweis v. TSH-Rez. in Orbita >E. Orbitafett/ Tränendrüsen/ Augenmuskeln >Verdickung, falls chron. Degenerat., Kompression Optikusatrophy >Erblindungsgefahr
Orbitaphlegmone	Sz. Orbita + Bulbus bei Bew., rote geschwollene Augenlider, Exophthalmus, Motilitätsstörung, red. AZ (Fieber), Visusverlust, Farbsehen ↘	Inspektion, Visus, Farbsinn (Farbverlust), Motilität (Motilitätsstörung), Pupillen (RAPD), Fundus	CT >Ausschluss Abszess!, ev. HNO-Konsil (denn oft i.R. Sinusitiden)	AB , ev. Sanierung NNH, Hospitalisation Prognose bei früher Th. gut.	Postseptales Orbitaphlegmon gefährlicher als präseptal (dann Pat. relativ guter AZ). Oft fortgeleitete Sinusitis, Sepsis.
Blow-Out-Fx (Orbitaboden-Fx)	Sz., Enophthalmus, Schielen/DB, Hypästhesie N. Maxillaris V2	Visus, Motilität (Inkonk. Schielen), Lufttemphysem, Sensibilitätsausfall N. infraorbitalis (gesamten Trigeminus prüfen, evtl. alle HN)	CT (Rx schlecht)	AB, Schnelverbot (Infektgefahr), Chirurgie falls Augenmotilitätsstörung + ev. Orbitabodenrevision (Platte)	
Trauma	Sz., rotes Auge, Visusabnahme, ev. Perf., ev. Penetration, ev. Bulbusberstung, variabel	Visus, Motilität, vorderes Auge (Hyphäma, Sidel positiv, Erosio, Perf., Iridodialyse, etc.), Lufttemphysem, Sensibilität, Fundoskopie (alles möglich)	CT (Lage + Anzahl FK, Verletzungsart), US	Schnell Naht (vorher CT >Entf. FK am nächsten Tag möglich ausser Holz/Kupfer/Draht!), Tetanusrapell, AB, Versorgung NH weiterer Defekte, bei V.a. Bulbusberstung >chirurg. Exploration, Vitrektomie (nach ca. 10 T.), nüchtern	HA: Kein Verband od. nur lockere Ovale, Auge n. berühren. Sidel-Z: falls Fluoreszin ausgewaschen wird weil Flüss. Aus Perf./Penetr.-Stelle austritt Gefahr Endophthalmitis!
Retrobulbärneuritis (Optikusneuritis)	Visusabfall, GF-Ausfälle, Dunklersehen, Kontrastsehen schlecht, Farbsinnstörung, Sz. bei Augenbew., oft junge Frauen, Pat. + Arzt sehen beide nichts, Rotationsstörung (Farbsinnstörung)	Visus, GF (Zentralskotom), Farbsinn (Störung), Pupille (RAPD), Motilität (Sz.), vorderes Auge, Fundoskopie (Papille unauffällig)	LP zur Dx-Sicherung, MRI (Optikus nimmt KM auf) MRI, denn kann 1. Zeichen v. MS sein.	Hochdosiert Steroide i.v.	Papillitis: ähnlich, nur dass Papillenschwellung (F-Skopie) Oft Junge (<30) Frauen, erfolgt v. Stunden bis Tagen

Uveitis	Akut rotes Auge, Sz. (u.a. bei Akommodation), Photophobie, ev. Visusabfall (GK-Blutung od. Makulaödem), Rötung, Sz. RF: Katze (Toxoplasmose), Medis, SS (autoimmun); Systemerkrankung (Bechterew, Arthritis, M. Behcet, etc.) Oft Glaukomanfall als Folge (Synechien)	Visus, Augendruck (↘ falls Ziliarkörper n. gut arbeitet), vorderes Auge (E-Zellen in VK, „Tyndal-Effekt, „Keratopräzipitate, ev. Hypopyon, ev. Synechien), Fundoskopie	Syphilis- „ Toxoplasmose Screening machen, OCT (sieht allfälliges Makulaödem falls posteriore Uveitis), Fluoreszenzangiographie (Schrankenstörungen, Stenosen, etc.) „Trübung Kammerwasser durch E.-Zellen „Ablagerungen E.-Zellen an Cornea-Rückseite	1. Steroide (U. anterior: Kortisontrpf., U. med. + post. Kortisoninjekt. peri- od. intraokulär od. system. Tbl.) 2. Immunsupr. (Azathioprin, Methotrexat >weniger Steroide) 3. Biologicals (Remicade/Infliximab, Humira) 4. Mydriatica-Trpf. (v.a. bei Iritis) 5. Kausale Th. falls Ursache klar	Ursache in 50% idiop., 40% Systemerk., 10% infektiös E.-Lokalisation: anteriore (zw. Iris + HH), media (v.a. GK) od. posteriore U. (Choroidea). Meist anterior. Post. U. oft wegen Toxoplasmose >kongenital od. erworben Oft Rezidive, Gefahr Komplik.
Lid-Befunde: Dermatochalase (Augenlid hängt herunter), Ptose (Augenlidmuskel schlecht), Xanthelasmen (Cholesterinablagerung), Distichiasis (zweite Reihe Wimpern), Poliosis (weisse Wimpern), Ektropium (gegen aussen), Entropium (gegen innen), Meibomitis, Konjunktivitis		Inspektion (Lidrand symm., Iris 2mm bedeckt, temporale Lidränder höher), Ektropionieren, Lidrand-Reflex-Distanz (Ptose?), Levator-Funktion, Lidfalte (falls keine so ist Ptose kongenital), Snap-Test mit Unterlid (M. orbicularis oculi)	Falls Trauma CT		Levatorfunktion: braue fixieren, Pat. soll nach oben blicken. Falls Funktion ok + Ptose >Levatordehiszenz, sonst Kongenital/Lähmung/Myopathie
Lid-Tumoren: Chalzion (granulomatöse Entzündung Meibom-Dr.), Hordeolum (Eitrige Entzündung Talgdrüsen und Lid), Molluscum contagiosum (Parapoxviren), Keratoakanthom Basaliom, Platten-EP-Ca, Talgdrüsen-Ca, Melanom			Biopsie ev.		
Lidphlegmon	Druck-Sz. am Lid, Schwellung, Rötung, im Gg. zu Orbitaphlegmon ist Motilität ok (keine DB), intraokulär reizfrei, Visus gut, AZ gut, ev. Fieber, oft i.R. Sinusitis	Visus, Motilität/Doppelbilder, Pupillenreaktion, vorderes Auge, Funduskopie	Ev. NNH-Orbita-CT, ev. HNO-Konsil, bei Kindern ev. Hospital.	AB, Umschlag mit Antiseptikum	
Endophthalmitis	Rotes Auge, Schmerzen, Visusabfall	Inspektion, Visus, GF, vorderes Auge (trübe HH, VK-Zellen, GK-Infiltration, Hypopion), Fundoskopie, Augendruck (DD acuter Glaukomanfall), Pupillenreflex		AB, Hospitalisation	Infektion Auge/Bulbus, meist bakteriell, oft post-FK (Holz, Draht) od. post-chirurgisch (z.B. Kataraktops). Prognose s. schlecht!
Tränenwegsstenose (Aplasie, Phimose, Pers. Hasnerklappe)	Tränendes Auge, Schwellung, Sz., ev. Abszess, Kruste, Schleim, ev. Rhinitis, z.T. Eiter			Spülung, Sondierung, Erweiterung, ev. Chirurgie	Bei Kindern oft pers. Hasnersche Klappe Ursache (tränendes Auge) >bis 1J. abwarten, denn oft Spontanheilung

Refraktionsanomalie	Myopie: unscharf in Ferne Hyperopie: unscharf in Nähe, astenothop. Beschwerden (Kopf-Sz.), Strabismus/DB wegen Akomm. Lindse Presbyopie (Alterssichtigkeit): unscharf in Nähe (Lesen), asthenot. Beschwerden beim Lesen	Visus, vorderes Auge, Fundoskopie, GF, Pupillen, Augenmotilität	Subj. Refraktion bestimmen mit Gläserkasten, ev. moderne Methoden (Skiaskopie >obj. Refraktion): Sphäre (Myopie, Hyperopie), Zylinder-Achse + -stärke (Astigmat.)	Brille (Fern-, Nahbrille, bifokale Gläser, Gleitsichtgläser) KL IOL Laser HH	Myopie: NH-Ablatio, Neovaskul. Hyperopie: Engwinkelglaukom Astigmatismus: HH-Verkrümmung Anisometropie: bei Katarakt-Ops z.T. gewollt damit keine Brille nötig, Gefahr Amblyopie, Aniseikonie
Erbliche NH-Pathologien	Zapfendystrophien: Farbensehen↘, Zentralskotom, Visus↘ (Lesen), Photophobie, ev. Erblindung →multifo. ERG, OCT, keine kurat. Th., stark getönte Gläser + Miotika Stäbchendystrophien (Retinitis pigmentosa z.B.): Dunkel- + Nachtsehen↘, periphere GF-Ausfälle →Ganzfeld-ERG M. Stargardt : Visusminderung bds., Farbsehen↘, zentrale + parazentrale GF-Ausfälle →EOG + multif. ERG M. Best: Visus normal od. red., Metamorphopsien, Verschwommensehen, GF + Farbsinn meist ok →EOG + mutif. ERG Wichtig: bei allen Gen-Analyse + Familienanalyse , vergrösserte Sehhilfen, Verlaufskontrollen ,keine kausale Th.				Status: Visus, GF, vorderes Auge, RAPD, Fundus (sieht meist nichts) >Spezialunters. Nötig M. Stargardt: ABCA4-Gen, häufigste Dystrophie, oft schon in Kindheit, b M. Best: VMD2-Gen, milder, beste Prognose
Rotes Auge	DD: Auge: Konunktivitis, Keratitis, Skleritis, Uveitis, Glaukomanfall bei WBG, Hyposphagma Umgebung: Blepharitis, Lidphlegmon, Allergie, Hordeolum, Dakryoadenitis, Orbitaphlegmone, Sinus-Cav.-Thrombose				
Plötzlicher Sehverlust	Organbefund: Glaukomanfall, Arterienverschluss, NH-Ablösung, GK-Blutung, Protusio bulbi (z.B. i.R. Hämatom od. Tumor), Amaurosis fugax (vorübergehend) Ohne Organbefund: CVI (homonyme Hemianopsie), Migräne (Aura: ondulierende Farbringe meist bds., GF-Ausfall, Schwinden, Beginn zentral >wandert nach peripher), Synkope, akuter Hirndruck, Chiasmablutung (bitemp. Hemianopsie)				
GF-Ausfall/Skotom	Uni- od. bilateral, nasal od. temporal, zentral (AMD oder Zapfendystrophie) od. peripher (Glaukom oder Stäbchendystrophie), neurolog. Ausfälle, Trauma, B-Symptome	Visus, Farbsinn, GF, Motilität, Pupillenreaktion (RAPD) + Konvergenz + Swinging-Flash-Light, Fundoskopie	Bildgebung (CVI, Trauma, RF)	Papille (einseitig, horizontal), Optikus (Zentralskotom), Chiasma (bitemp. Hemianopsie), Tractus + Sehbahn + VI (homonyme Hemianopsie, einmal nasal und einmal lateral). RAPD falls Läsion zw. Papille + vor Thalamus.	
Anisokorie (H. Syndrom, Adie'sPupille, Trauma, CVI)	Visus, GF, Motilität, Trauma, CVI	Visus, Farbsinn, GF, Motilität, Pupillenreaktion (RAPD) + Konvergenz + Swinging-Flash-Light, Fundoskopie			Störung Efferenz (Anisokorie, Strabismus, Hirnnervenparese) Horner: Anisokorie > im Dunkeln grösser (Keine Reaktion auf Cocain) Adie's: Anisokorie grösser im Hellen (Reagktion auf Pilocarpin)
RAPD (Optikusneuritis, AION, Glaukom, Tumor, CVI)	Visus, GF, Farbsinn, Trauma, CVI				Störung Afferenz (Visus, GF, RAPD) Beleuchtung krankes Auge: keine Miosis bds., ev. sogar leichte Mydriase Beleuchtung gesundes Auge: Miosis bds.
Tumoren am Auge	Lid: Hämangiom (verschwinden oft spontan, falls ganzes Auge verschlossen B-BI. damit keine Amblyopie), Pyogenes Granulom (exophytische Gefässprolif. Aus Gruppe d. Hämangiome), Nävus (Kontrollen weil selten Entartung zu Melanom), Keratokanthom (verhornendes Gewebe, sieht aus wie Brustwarze, Excision weil Entartung selten möglich), Virusnävus, Papillom Melanom, Basaliom (kraterförmig, zentrale Delle, Ulzera oft, nasale Lidwinkel oft), PE-Ca, Meibomdrüsen-Ca (therapieresistentes Chalazion/ Hordeolum)			Abklärungen: Biopsie, BE (Tumormarker), US (u.a. Leber-US weil oft Metastasen), ev. CT/MR Bei Hippel-Lindau: MRI (denn oft	Therapie: Generell 3-Säulen 1. Chirurgie (inkl. Kryoth. + Laser) 2. Radio (inkl. Brachyth.) 3. Chemo (Trpf., intravitreal, syst.)

	Tränendrüsen: Pleomorphes Adenom, Tränendrüsen-Ca Konjunktiva: Pterygium (reicht bis + mit HH, oft bei viel Sonne, Rezidive, macht Astigmatismus, häufiger in Mittelmeerraum), Pinguecula (nur BH-BH), epitheliale Melanosis (flache bewegliche braune Pigmentierungen, wenn einseitig bei Hellhäutigen biopsieren), kong. Melanosis oculi (flache bewegliche bläuliche Pigmentierungen, falls auch Haut >Nävus Ota), Nävus (erscheint meist in ersten 2 Lebensdekaden) PE-Ca (vaskularisierte fleischige unscharfe Masse mit Versorgungsgefäß, oft rosa), Melanom (v.a. ab 60j., i.d.r. schwarz-graues Knötchen mit zuführendem Gefäß, oft auf Sklera fixiert, selten amelanotisch, oft am Limbus) Iris: Lisch-Knötchen (NF I), Melanom (Pupille wird oft verzogen, erhaben) Ziliarkörper: Melanom (oft zu spät dx) Choroidea: Nävus (scharf begr., Papille n. infiltriert, kein Niveau, homogen), Melanom (Niveau, unscharf, ev. Ablatio) NH: Astrozytom, Hämangiom, Hippel-Lindau-Erkrankung Retinoblastom (Leukokurie, Tumor d. Photorez., ein- od. bds.), Hippel-Lindau-Erkrankung (assoz. mit NZK), Metastasen (Leopardenmuster) Orbita: Phlegmon, Dermoidzyste, Hämangiom, Meningeom, O-Gliom, MELANOM am häufigsten!!!! Rhabdomyosarkom, Lymphom, Tränendrüsen-Ca	ZNS- + Nieren-Tumoren) Anamnese: Visus→, GF-Ausfall, FK- + Druckgefühl, Sz., B-Symptome Status Inspektion, Visus, GF, Pupille, vorderes Auge, Fundus, LK, internist. Status	Melanom: Kryoth., Radio, Excision, ev. Enukleation Retinoblastom: Kryo, Chemo, ev. Brachyther., selten Enukleation
--	--	--	--

*ANAMNESE: **6 Dimensionen**; **PA** (Linsen, Brille, Ops, Sehprobleme, Schielen), **FA**; **RF's** (Hypertonie, DM, Rauchen, Alkohol, Linsen, Ops Auge; Medis)**Medis** (Steroide, AB, Chinolone, Mydriatika, OAK, Tuberkulostatika etc.); **Allergien**, **B-Symptome**, **HNO-Organ** (Ohr, Nase, etc.)

** **LK + z.T. Neurostatus/Sens.** nicht vergessen